

Secretaria da Saúde



Procedimento Operacional Padrão – POP

Data de Emissão	Data de Aprovação	Data da Vigência	Próxima Revisão	Versão	Rotina	Pagina
27/10/2020	27/10/2020	27/10/2022	27/10/2022	nº 01	nº 31	01 de 04

Nome do Procedimento: Teste de Eletroforese de Hemoglobina – Pesquisa Hemoglobinopatias em Gestantes – TESTE MÃE CATARINENSE

Área: Diretoria de Atenção Primária à Saúde

Setor: Enfermagem

Executantes: Enfermeiros

Objetivo: Orientar os servidores envolvidos na atividade da realização da técnica de coleta do teste de eletroforese de hemoglobina em gestantes – TESTE MÃE CATARINENSE.

Recursos necessários:

- Pia com água para lavagem das mãos;
- Dispenser de sabão;
- Dispenser de papel toalha;
- Sabonete ou detergente líquidos;
- Papel toalha;
- Álcool 70%;
- Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para coleta: máscara, óculos e luvas de procedimento;
- Lanceta retrátil, descartável, fornecida pela Fundação Ecumênica ao Excepcional (FEPE);
- Algodão e/ou gaze pequena;
- Lixeira para descarte de material comum;
- Lixeira para descarte de material infectante;
- Caixa de descarte para material perfuro cortante;
- Definição de local adequado para a secagem dos filtros coletados (Estante);
- Ficha de coleta;
- Lista nominal de mães;
- Envelope para papel filtro;
- Estante própria para secagem;
- Livro de registro.

Descrição:

O teste Mãe Catarinense permite identificar em gestantes hemoglobinopatias como a Doença Falciforme, traço Falciforme e Talassemia Major. A Anemia Facilforme é uma das doenças hereditárias mais comuns no Brasil e no mundo. Ela promove alteração das moléculas de hemoglobina que assumem a forma de foice, daí o nome de Facilforme, ocasionando encurtamento da vida média dos glóbulos vermelhos, fenômeno de vaso oclusão, episódios de dor e lesão de órgãos. A Doença Falciforme não é contraindicação para a gravidez, mas a gravidez é uma situação potencialmente grave para as mulheres com essa doença, assim como para o feto e para o recém-nascido.

Aplicação:

A UBS deverá coletar o sangue da gestante para o exame da eletroforese de hemoglobina preferencialmente no primeiro trimestre da gestação. Como o exame também será realizado por punção transcutânea (punção digital) para facilitar o processo de trabalho das equipes, orientamos

que esse exame seja coletado no mesmo momento da realização dos Testes Rápidos das gestantes; entretanto, é necessário ter cuidado para que não ocorra contaminação do papel filtro por possíveis respingos dos reagentes ou solução tampão dos Testes Rápidos.

Técnica da Coleta



1. Antes de iniciar a coleta, o profissional de saúde deve separar os materiais: ficha de coleta, lanceta, álcool 70%, algodão ou gaze, envelope, lista nominal de gestantes, luvas de procedimento.



2. Solicitar documentação da gestante e preencher a ficha de coleta, todos os campos, bem como a Lista Nominal de Gestantes, de modo completo.



3. A coleta de sangue para realização do exame “eletroforese de hemoglobina” em gestantes deve ser efetuada, preferencialmente, no 1º trimestre de gestação, por profissional de saúde da Unidade de Atenção Primária à Saúde.



4. O profissional de saúde deverá informar à gestante sobre o objetivo do exame e como será o procedimento. Explicar de forma simples, que se trata de doenças hereditárias, que causam anemias. Este teste permite identificar as anemias que não aquelas causadas por deficiência de ferro, mas por alteração genética como a Doença Falciforme. A realização deste exame é importante, pois a gravidez é uma situação potencialmente grave para as pacientes com estas patologias, assim como para o feto e para o recém-nascido.



5. Lavar bem as mãos com água e sabão, seguido de desinfecção com álcool 70%. Não se esquecer de calçar as luvas de procedimento.



6. Solicitar a gestante para lavar bem as mãos com água e sabão e secar bem. Observar os dedos da gestante e escolher a ponta do dedo médio, anelar ou indicador, ou o dedo que tiver menos calosidade. Se a mão da gestante estiver muito fria, o fluxo de sangue estará diminuído, dificultando a coleta de sangue. Aqueça a mão massageando-a ativamente ou, se possível, utilize uma bolsa de água quente ou compressa umedecida em água quente. Lembre-se de secar bem os dedos da gestante antes de fazer a punção.



7. Segurar a mão da gestante com o lado da palma para cima, numa altura abaixo do cotovelo. Pressionar levemente a mão na direção do punho para o dedo no qual será realizada a punção;



8. Após, realizar antisepsia do local onde será puncionado, com algodão limpo embebido em álcool a 70%. Deixar o álcool secar espontaneamente ou secar com gaze ou algodão estéril. Não assoprar para acelerar a secagem, pois este procedimento leva à contaminação da área da punção. O dedo a ser puncionado deve estar bem seco;

	9. O profissional de saúde deve, então, proceder à punção com a lanceta retrátil, pressionando firmemente a lanceta contra o dedo; 10. Pressionar o dedo da gestante próximo ao local da punção para formar uma gota de sangue. Manter a mão da gestante levemente.
 	11. Preencher os dois círculos do papel filtro, de modo completo, homogêneo, certificando-se de que os mesmos tenham absorvido e preenchido de sangue, completamente, os dois lados do papel filtro. Não há problema caso o sangue saia para fora do círculo. 12. Solicitar à gestante que segure firmemente o local puncionado, com uma gaze ou algodão durante alguns segundos. Após cessar o fluxo de sangue, desprezar o algodão sujo em recipiente próprio para material potencialmente infectante.
	13. Após o preenchimento dos campos do papel filtro com o sangue coletado, a ficha deverá ser colocada em posição horizontal, em estante própria. Deixar secar longe da luz solar, ar condicionado ou estufa, por no mínimo 2 horas; 14. Os materiais utilizados na coleta devem ser descartados seguindo-se as normas de descarte para material biológico e resíduo infectocontagioso.
	15. Um canhoto informativo que consta da ficha de coleta deve ser destacado e entregue a gestante. Neste informativo há orientações de como acessar o resultado do exame.
   Lista Nominal de Gestantes Preencher e enviar junto com o material coletado	16. Preencha todos os campos da lista nominal de gestantes. O responsável na Unidade Básica de Saúde (UBS) pelo encaminhamento do material à FEPE deverá verificar nas fichas de coleta, se o cadastro está adequadamente preenchido e o sangue corretamente coletado, para não motivar reconvocação por má coleta. Encaminhar, junto com as fichas de coleta, a Lista Nominal de Gestantes preenchida; 17. O material coletado do “Mãe Catarinense” poderá ser encaminhado à FEPE junto ao material coletado do “Teste do Pezinho”, no mesmo envelope de porte pago, diariamente. Não recomendamos o uso da caixa de correio devido a possibilidade de ressecamento do sangue. Utilize as Agências de Correio; 18. Não retenha amostras coletadas na Unidade de Saúde. Se possível, encaminhe todos os dias; 19. Caso o resultado seja positivo, siga as orientações do fluxograma disponível no endereço eletrônico: http://www.fepe.org.br/teste-da-maezinha/legislacao-sc/. Para mais informações, consulte a Deliberação 057/CBI/2019, no mesmo endereço eletrônico.

Observação: Para registrar o procedimento no Sistema Integrado de Gestão (SIG-SAUDETECH), no ambiente consultório informatizado:

- ✓ Recepcionar a usuária com objetivo, PRENATAL 1ª ou PRENATAL RET e clicar em adicionar procedimento;
- ✓ Digitar “**HEMOGLOBINA**” no campo de busca e selecionar o código de procedimento **99001899**: Punção digital para pesquisa de hemoglobinopatias em gestantes, (PMV) para lançamento;
- ✓ Monitorar o resultado para os devidos encaminhamentos e orientações (qualquer profissional da Equipe da Unidade de Saúde);
- ✓ Registrar o resultado em “**Avaliação de Exames**”, busca → “**punção digital**”, seleciona o exame → “**punção digital para pesquisa de hemoglobinopatias em gestantes**”, nos campos

indicados, anotar a data de referência do exame e transcreve o resultado no campo “**descrição**” e finalizar → “**gravar**”;

- ✓ Anotar o resultado também nos dados permanentes do prontuário da gestante, pois caso venha a ocorrer futuras gestações, o exame não precisará de coletado novamente. Fica a critério da Equipe a confecção de um livro de registros de coleta ou planilha para controle.

Importante:

- ✓ **Este exame é realizado uma única vez, mesmo na ocorrência de novas gestações não é necessária nova realização;**
- ✓ As Unidades receberão um adesivo com o número do CNES, que deverá ser fixado em local visível, na sala de coleta; este número sempre deverá ser anotado na ficha de coleta no campo específico e no envelope.

Referências:

1. ESTADO DE SANTA CATARINA. Secretaria do Estado da Saúde. Superintendente de Serviços Especializados e Regulação. Superintendência de Planejamento em Saúde. Diretoria de Atenção Primária à Saúde. Deliberação 057/CBI/2019. Teste Mãe Catarinense. Florianópolis – SC:2019.
2. FUNDAÇÃO ECUMENICA DE PROTEÇÃO AO EXCEPCIONAL (FEPE). Programa Nacional de Triagem Neonatal. Serviço de Referência em Triagem Neonatal no Paraná. Manual Técnico de Coleta para o Teste do Pezinho. Curitiba – PR: 2013.

Elaborado por: Fernanda Cristina Spiller Gyovana da Rosa Goulart	Revisado por: Fernanda Cristina Spiller Renata Andrade Teixeira Heil	Aprovado por: Fernanda Cristina Spiller
Acesso	Disponível pelo Endereço Eletrônico	
Sistema de Informação SES/Joinville – INTRANET	Pub. Documentos / Coordenação de Enfermagem / Procedimentos Operacionais Padrão; Pub. Documento / Coordenação Estratégia Saúde da Família / Saúde da Mulher.	
Sistema Eletrônico de Informação (SEI)	Processo SEI 20.0.161521-8	

Alteração após Revisão			
Nº	Data	Responsável	Alteração